SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUROLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	01/09/2021
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Motivo de ingreso / Motiu d'ingrés

Mujer de 82 años de edad que ingresa por ENFERMEDAD COMUN procedente de Hospital General de Castelló - URG. GENERALES

Antecedentes / Antecedents

Natural de Navarra aunque vive en Las Useras con su pareja (8 años). *RAM: niega. *Antecedentes personales: - No FRCV - Elevación de Hemidiafragma derecho. - TEP bilateral en 2016+TVP, en tratamiento con Xarelto un tiempo. - SAOS + BIPAP. - Consulta en URG el 18/07/2021 por disnea progresiva de 1 mes de evolución. - El hermano (que vive fuera) niega problemas cognitivos. La pareja si refiere algun despiste los últimos meses (pero anamnesis limitada por idioma). Tb es posible que presentara un AIT, que no se llegó a consultar Ecocardiografía (2017) Diámetro diastólico VI: 40 mm Diámetro sistólico VI: 20 mm Grosor septo: 10 mm Grosor PP: 9 mm Aurícula izquierda: 37 mm Raíz aórtica: 27 mm Fracción eyección VI Teichholz: 76 % Masa VI: 107 g 2D Área AI: 16 cm² 2D VD TAPSE: 22 mm Conclusiones: AD no dilatada. VD no dilatado con FS conservada. Tronco de AP no dilatado. No se visualizan correctamente las ramas pulmonares. AI no dilatada. Raíz aórtica de tamaño normal. Ventrículo izquierdo de dimensiones normales y función sistólica conservada. FE estimada >65%. No se aprecian alteraciones de contractilidad segmentaria. Válvulas de estructura normal. Doppler valvular sin alteraciones significativas. IT ligera que permite estimar una PsAP de 25-30 mmHg. No signos indirectos de HTP. VCI no dilatada con adecuado colapso inspiratorio. Ausencia de derrame pericárdico. CONCLUSIONES: Ecocardiografía dentro de la normalidad. *Fármacos de uso habitual: - Seguril ocasional - Spiriva ocasional (tiotropio). *Social: vive con pareja. Independiente para ABVD e instrumentales. Barthel 100. Rankin 0 Trabajó de recepcionista hasta los 63 años. *Hábitos tóxicos: no fumadora; bebedora de 2 copas de vino blanco para comer todos los días. ** Dificil anamnesis por barrera idiomática con la pareja (frances y conversación telefónica, en urgencias) y por estado ebrio de la paciente a su lingreso.

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual

---------- URGENCIAS ----------

Mujer de 82 años de edad que ingresa la madrugada del día 01/09/2021.
En Abucasis consta contacto del 31/08/2021 a las 00:01h con su médico de atención primaria, que acudió a su domicilio: según su marido (y la propia paciente que también lo recuerda), el día 30/08/2021 estuvieron con unos amigos, celebrando un cumpleaños y la paciente bebió algo más de vino blanco y probablemente vermú.

**** Madrugada del 31/08/202: Médico de AP escribe "nos avisan a acudir a domicilio por baja saturación de oxigeno objetivada con saturimetro de casa. Al acudir paciente aparentemente ebria sin BIPA. Ebria, consciente y orientada. SatO2 sin bipap 87% con BIPAP 96%.
Se le ajustó la BiPAP y se comprobó que no tenía fugas.
Se realiza un test de antígeno para COVID siendo negativo.

**** El día 31/08/2021 consta una llamada del marido al 112 a las 14:03h.
Se recibe otro aviso a las 00:00h del día 01/09/2021: valorada por la médico de AP cuando se remite a URG.

Según el marido, parece que desde la mañana del 31/08/2021 ya presenta dificultad para hablar y para movilizar el hemicuerpo izquierdo. Requiere ayuda para levantarla, lavarla y vestirla. Parece que no

bebe nada desde el 30/08/2021.

Remitida por médico de atención continuada 00.55H, avisa el marido porque nota que no habla bien y le cuesta moverla. La paciente refiere "torpeza" en hemicuerpo izquierdo. No dolor torácico. Afebril. Presenta hematoma en dorso mano derecho y en brazo izquierdo, al parecer ha caido pero no sabe especificar. Marido refiere que la última vez que la vió bien fue despues de la cena, sobre las 21h.

Exploración física / Exploració física

---------- URGENCIAS ----------
Constantes vitales: glucemia 108 mg/dl; TA: 142/57 mmHg; Tª: 36.9 ºC (Timpánica); FC: 50 lat/min; Sat. O2: 100 %.

AC: tonos regulares, sin soplos.
AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.

MMII: no edema.

Exploración Neurológica: alerta, orientada en persona, falla mes. MOES conservados. No hemianopsias por confrontación. Hemiparesia izda 4/5 en MS y 4-/5 en MI. Refiere hipoestesia al pinchazo. No dismetrias d-n. Extinción no valorable. Disartria moderada. NIHSS 5 puntos.

Test de los 3 tragos: tose en el segundo

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries

----------URGENCIAS---------- Gasometría PH SANGUINEO: 7,370 [(7.350-7.450)] ; PCO2 SANGUINEO: 39,0 mmHg [(35.0-45.0)] ; PO2 SANGUINEO: 83,0 mmHg [(69.0-115.0)] ; CO2 total: 23,7 mmol/L; EXCESO BASE ACTUAL: -2,5 mmol/L [(-2.4-2.3)] ; EXCESO BASE STANDARD: -2,8 mmol/L [(-2.5-2.5)] ; BICARBONATO ACTUAL: 22,5 mmol/L [(22.0-26.0)] ; BICARBONATO STD: 22,9 mmol/L [(22.0-28.0)] ; SATURACION OXIGENO: 97,8 % [(95.0-99.0)] ; OXIHEMOGLOBINA: 95,70 % [(94.00-97.00)] ; CARBOXIHEMOGLOBINA: 1,40 % [(1.50-5.00)] ; METAHEMOGLOBINA: 0,70 % [(0.40-1.50)] ; HEMOGLOBINA REDUCIDA: 2,20 % [(0.10-5.00)] ; BIOQUÍMICA GLUCOSA 117 mg/dL * (70 - 110) UREA 30 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA 0,66 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 81,99 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 138 mmol/L (134-145) POTASIO 3,98 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 105 mmol/L * (95-105) PROTEINA C REACTIVA 6,97 mg/L (1.00-10.0) HEMOGRAMA T. PROTROMBINA 10,4 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK 120,0 % (70,0 - 120,0) INR 0,90 (0,80 - 1,20) TP RATIO 0,90 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO 0,90 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 28,3 seg (25,1 - 32.5) FIBRINOGENO 306,00 mg/dL (200,00 - 400,00) HEMOGRAMA HEMATIES 4,31 x 10^6/µL (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 13,8 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 40,3 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 93,6 fL (80 - 94) LEUCOCITOS 9,70 x 10^3/µL (4,80 - 10,80) NEUTROFILOS 5,20 x 10^3/µL (1,90 - 8,00) LINFOCITOS 3,00 x 10^3/µL (0,90 - 5,20) MONOCITOS 1,30 x 10^3/µL * (0,16 - 1,00) EOSINOFILOS 0,20 x 10^3/µL (0,00 - 0,80) BASOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,20) PLAQUETAS 211 x 10^3/µL (130 - 400) ECG: Bradicardia sinusal 53 lpm, eje qrs 60º, PR de 200 ms, qrs estrecho con morfología de BIRDHH, onda T invertida en v1-v2, adecuada progresión RS en precordiales, QTC normal. RX TÓRAX: elevación hemidiafragma derecho. TC CRÁNEO Y ANGIO-TC: sin sangrado ni lesión isquémica aguda. Oclusión ACI I ----------UNIDAD DE ICTUS/NEUROLOGÍA---------- BIOQUIMICA GLUCOSA 120 mg/dL * (70 - 110) UREA 25 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA 0,68 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 81,23 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 139 mmol/L (134-145)

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUROLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	01/09/2021
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

POTASIO 4,02 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 108 mmol/L * (95-105) CALCIO 8,9 mg/dL (8.5-10.5) CALCIO CORREGIDO 9,5 mg/dL (8,5 - 10,5) FOSFORO 2,2 mg/dL * (2.5-4.5) PROTEINAS TOTALES 5,74 g/dL * (6,60 - 8,00) ALBUMINA 3,30 g/dL * (3,50 - 5,20) BILIRRUBINA TOTAL 0,58 mg/dL (0.50-1.0) COLESTEROL 243 mg/dL * (140-220) HDL COLESTEROL 51 mg/dL (40-65) LDL COLESTEROL CALCULADO 160 mg/dL * (50 - 150) TRIGLICERIDOS 155 mg/dL * (50.0-165.0) GPT 12 UI/L (10-37) GGT 66 UI/L * (7.0-50) FOSFATASA ALCALINA 80 UI/L (40-145) CPK 278 UI/L * (50-195.0) LDH 147 UI/L (0 - 248) PROTEINA C REACTIVA 9,77 mg/L (1.00-10.0) GLICOHEMOGLOBINA A1C (%) 6,11 % (4.0 - 6.5) TSH 3ª GENERACIÓN 0,673 mUI/L (0,380 - 5,330) T4 LIBRE 0,98 ng/dL (0,54 - 1,24) FOLICO 17,17 ng/mL * (4.00 - 16.0) VITAMINA B12 (COBALAMINA) 207,0 pg/mL (180,0 - 914,0) HEMATOLOGIA T. PROTROMBINA 10,8 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK 112,0 % (70,0 - 120,0) INR 0,94 (0,80 - 1,20) TP RATIO 0,94 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO 0,92 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 28,9 seg (25,1 - 32.5) FIBRINOGENO 327,00 mg/dL (200,00 - 400,00) HEMATIES 4,14 x 10^6/µL * (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 13,3 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 38,9 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 94,1 fL * (80 - 94) HBG CORPUSCULAR MEDIA 32,1 pg * (27,0 - 31,0) CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA 34,1 g/dL (33,0 - 37,0) NEUTROFILOS % 58,9 % (40,0 - 70,0) LINFOCITOS % 28,9 % (19,0 - 48,0) MONOCITOS % 10,2 % * (3,4 - 9,0) EOSINOFILOS % 1,4 % (0,0 - 7,0) BASOFILOS % 0,6 % (0,0 - 1,5) PLAQUETAS 213 x 10^3/µL (130 - 400) HEMOSTASIA BÁSICA T. PROTROMBINA 10,4 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK 120,0 % (70,0 - 120,0) *ATENCIÓN*: Este valor se interpreta como =100%. INR 0,90 (0,80 - 1,20) TP RATIO 0,90 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO 0,90 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 28,3 seg (25,1 - 32.5) FIBRINOGENO 306,00 mg/dL (200,00 - 400,00) RM CEREBRO Y RM VASCULAR CEREBRO 01/09/2021: Infarto agudo paramediano derecho en la protuberancia de 7x18 mm. Focos isquémicos crónicos en coronas radiadas que muestran áreas de confluencia por lo que se categoriza como Fazekas II. Área de gliosis córtico-subcortical parietal derecha en relación con infarto antiguo. Depósito metálico de carácter inespecífico en ambos pálidos. Discreta pérdida difusa del parénquima supra e infratentorial con dilatación ventricular compesadora. Trombosis ya conocida del segmento intracraneal de la carótida interna izquierda. Listesis I/IV a nivel de C4-C5 sin presencia de lisis. Sin otros hallazgos relevantes. ANGIOTC PULMONAR para estudio de disnea 07/09/2021: No se objetivan defectos de repleción en arterias pulmonares principales ni en sus ramas lobares ni segmentarias. Patrón de perfusión en mosaico bilateral y difuso, que aunque ya estaba presente en el estudio previo es más marcado actualmente, sugiere tratarse de alteraciones perfusionales. Placas de engrosamiento pleural parcialmente calcificadas, de predominio en campo medio y base derechas. El resto del estudio no muestra otros cambios reseñables: Pequeñas bronquiectasias cilíndricas/arrosariadas localizadas en lóbulo inferior izquierdo y língula, asociadas a atelectasias laminares retráctiles. Engrosamiento apical bilateral. No derrame pleural. Sin presencia de adenopatías. Bocio endotorácico a expensas le lobulo izquierdo, con desplazamiento contralateral traqueal y esofágico. Gran elevación hemidiafragmática derecha. Hipotrofia renal derecha. Signos degenerativos en columna dorsal, que han progresado respecto al estudio previo. Conclusión. No se evidencia TEP. Monitor ECG: RS IC RHB Paciente de 82 años en su 1r día de ingreso en UI. Paciente algo desorientada, no recuerda muy bien qué pasó ayer pero es consciente que tiene un ictus que no le deja mover la pierna, no da interés al brazo. En el momento del examen despierta, orientada TEP (edad), obedece órdenes símples y complejas. PICNR, no alteraciones PPCC impresiona leve hemianopsia ipsilateral, leve asimetría facial. BM hombro 4/5, codo y muñeca 3/5, incapáz de hacer puño completo ni extensión completa de dedos de la mano izquierda, pinza TT 2do dedo débil 3/5. BM flexores de cadera 3/5, flexoextensores rodilla 4/5, flexoextensores tobillo 4/5, Babinsky +. No alteración sensitiva al pinchazo. Dificultad / imposibilidad para realizar maniobras de dismetrías por debilidad en hemicuerpo izquierdo. Disartria leve-moderada. No alt del lenguaje. No afasia. No extinción sensitiva ni visual. PLAN:

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUROLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	01/09/2021
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

FST en habitaicón IC ENDOCRINOLOGIA. (1/9/21) Mujer de 82 años. - Ingresa en NRL por sospecha ictus isquémico que cursa como Sde lacunar motor-sensitivo izquierdo. Angio TC de ingreso hallazgo de oclusión de ACI izquierda. Otros AP: No RAM Obesidad. Portadora de BIPAP. Antecedente de TEP bilateral en 2016 Elevación hemidiafragma derecho. Bebedora habitual de vino y cerveza (al parecer llegó a URG en estado ebrio) Solicitan valoración por bocio endotorácico objetivado en TC torácico al ingreso. Se observa bocio endotorácico que desplaza tráquea hacia la derecha. Anamnesis dirigida: Al parecer en seguimiento por ECR privado, estaba pendiente de una ecografía tiroidea por bocio de larga evolución. Niega clínica compresiva. No ha presentado disfagia ni otra sintomatología. La disnea la describe como de meses de evolución sobre todo al realizar esfuerzos (reviso último evolutivo de Neumología julio 2021: ("habiendo de parar al subir las escaleras. Hace una semana, viaje a Francia, tras lo cual, empeoramiento hasta hoy que inicia disnea brusca. Saturaciones en casa sobre 85%). Usuaria de BIPAP. Peso: 62 kg Talla: 152 cm IMC: 27 Dificil palpación gl.tiroidea por cuello corto, obesidad y dificultad para incorporarse. TC previo 2017: Persiste el bocio endotorácico izquierdo ya conocido. Tiene unas medidas de 3 x 3 x 5 cm de ejes máximos, llegando la porción endotorácica hasta la altura de la salida de los troncos supraaórticos. Función tiroidea dentro de la normalidad (sept 2021) TSH 3ª GENERACIÓN 0,673 mUI/L (0,380 - 5,330) T4 LIBRE 0,98 ng/dL (0,54 - 1,24) PLAN: El bocio endotorácico izquierdo es de años de evolución (visualizado desde por lo menos 2017), niega clínica compresiva, tampoco molestias en región topográfica de tiroides, no disfagia (de manera puntual le cuesta tomarse las pastillas, no siempre, niega problemas con la ingesta de alimentos y líquidos), por lo que no parece justificar la disnea actual que presenta la paciente (impresiona de multifactorial (atcd de EPOC, sobrepeso, portadora de BIPAP, empeora con los esfuerzos, atcd de EPOC), en cualquier caso solicitamos ecografía tiroidea que nunca se ha realizado, para correcta caracterización. (6/9/21) Reviso las imágenes del TC del ingreso y realmente tiene crecimiento de bocio bilateral, mayor en su componente derecho que progresa a nivel endotorácico, por debajo del manubuiro esternal. Desplaza tráquea con discreta compresión pero manteniendo buena luz Eutiroidea Dado la edad y antecedentes atológicos, en ausencia de clínica compresiva cervical (la disnea no parece atribuible a este proceso), es poco probable que se considere a la paciente candidata a cirugía tiroidea. Plan: - Al alta remitir a la paciente a su endocrinólogo de zona para seguimiento - La ECO se puede realizar ambulatoriamente, ya que no será determinante de la actitud a tomar DIETISTA-NUTRICIONISTA Resumen: Mujer de 82 años ingresada en NRL por sospecha ictus isquémico que cursa como Sdr. lacunar motor-sensitivo izquierdo. Solicitan valoración de disfagia. AM de interés: Obesidad. Portadora de BIPAP. Antecedente de TEP bilateral en 2016. Elevación hemidiafragma derecho. Bebedora habitual de vino y cerveza (al parecer llegó a URG en estado ebrio). * TEST MECV-V realizado por enfermera especialista en disfagia el 3.9.21: Signos de pérdida de seguridad con textura líquida por lo que se explica al acompañante que debe utilizar espesante. Presenta disfagia a líquidos. Recomendaciones dietéticas: se dan al hermano --> Viscosidad más adecuada: néctar y Volumen: medios. ********** Seguimiento Nutricional Constantes bien. Refiere deglutir bien con las pautas dadas tras realización de test MECV-V. Las ingestas han ido mejorando a lo largo del ingreso, actualmente son del 75-100%. SNO: toma 0.5-1 botella al día. Probable ALTA hoy según notas de evolución. Por nuestra parte: - Damos pautas dietéticas por escrito para poder seguir las indicaciones en domicilio (se aporta menú triturado y menú fácil deglución). - Hacemos recetas de espesante (néctar). - Seguimiento por neurología/MAP . Finalizamos IC. Realicen nueva IC si precisan. IC TRABAJADOR SOCIAL (3/9/21) visito a la paciente y hablo con Pierre su pareja, me comenta que hasta el episodio actual era autónoma , viven en una masía en Les useres, comenta problemas de accesos a los recursos sanitarios de la zona, necesitarían servicios de ayuda a domicilio. intento hablar con servicios sociales de la zona pobles del nord-penyagolosa para conocer más

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUROLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	01/09/2021
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	14/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		NÚMERO Hª CLÍNICA NÚMERO Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

detalles , sin éxito (6/9/21) comento a su pareja Pierre que para tener tarjeta sip definitiva necesita estar empadronado en la comunidad valenciana , y tener así médico asignado. así como para poder hacer los trámites de dependencia. la pareja de la paciente comenta que es probable que una vez se le de el alta se vayan a navarra su otra residencia ya que allí tiene la tarjeta sanitaria definitiva. I/C NEUMOLOGÍA (2/9/21): Mujer de 82 años de edad conocida por vosotros, que ingresa por ictus isquémico lacunar motor puro izquierdo. AP de TEP en 2016 que recibió anticoagulación con rivaroxabán un tiempo. Elevación de hemidiafragma derecho conocida desde 2017. Presenta disnea en decúbito supino aunque mantiene correcta SatO2 92-93%; dejamos con GN a 2 lpm. En domicilio portadora de BiPAP. Interesa valoración. Gracias. ANTECEDENTES: Alergias: No RAMs conocidas Hábitos: ex-fumadora desde hace más de 40 años, 3-4 cig/día durante 10 años (de los 40 a los 50 a). - No HTA, no DM, no DL - TBC en la infancia con paquipleuritis derecha residual (en TC de Mayo 2017 no se evidenciaron signos de paquipleuritis, solo tractos engrosados apicales bilaterales, compatibles con cambios post TBC). - Elevación de hemidiafragma derecho. - Portadora de VMNI nocturna (puesta en Navarra). Nunca ha precisado OCD. - TVP +TEP en Francia 8/11/16, tras viaje prolongado en coche a Alemania --> anticoaglada con xarelto. ***Ecocardio Francia: VI no dilatado, sin hipertrofia y septo paradójico, FEVI 70-75%, Ao ascendente no dilatada, sin valvulopatias. VD Dilatado normocinetico, insuf tricuspideamoderada, PAPs 55-60 mmHg, HTP post embolia. ***TAC torácico tras administración de CIV. MAYO 2017 Tractos engrosados apicales bilaterales, compatibles con cambios post TBC. Elevación diafragmática derecha, debido probablemente a una relajación diafragmática,ya que se observa una la elevación del diafragma en toda su extensión. No hay signos radiológicos de paquipleuritis ni de otros cambios post tuberculosos excepto los ya descritos. Se observa un pequeño defecto de repleción en la arteria pulmonar derecha, sugestivo de tratarse de restos de su embolismo previo, habiéndose convertido en un tromboembolismo cronico. No hay cardiomegalia. Bocio endotorácico a expensas del LTI que tiene unas medidas de 3 x 3 x 5 cm de ejes máximos, llegando la porción endotorácica hasta la altura de la salida de los troncos supraaórticos. ***GA Mayo/2017: pH 7.41 pCO2 45 pO2 83 HCO3 27.5 Sat 96.3%. ***ESPIORMETRIA 2017 FVC 930 ML 38% FEV1 860 ML 52% FEV1/FVC 93 TBD NEGATIVO ***ANGIOTC TÓRAX AGOSTO'17: Se observa una gran elevación del hemidiafragma derecho. No se observan el estudio actual defectos de repleción en las arterias pulmonares sugestivos de TEP. No se aprecian alteraciones en parénquima pulmonar. Persiste el bocio endotorácico izquierdo ya conocido, así como la hipoplasia del polo inferior del riñón D. ***NT PROPEPTIDO NATRIURETICO BNP 58 pg/mL, DIMEROS D 320,00 ng/mL ***Ecodopler venoso Dic 2017: Se descarta Insuficiencia Venosa profunda bilateral. ***Ecografia cardiaca Nov 2017: Normal. FEVI>65%. No signos indirectos de HTP. Tto habitual (no constan en HFT): inhaladores (no sabe precisar cuales) + seguril a demanda según refiere. EA: Avisan por disnea, precisando oxígeno durante el ingreso (no portadora de OCD). Refieren disnea a pequeños esfuerzos y en decúbito, de muchos años de evolución, sin notar claro incremento en los últimos días. No edemas ni cambios en la diuresis. No tos, no expectoración, no sibilancias, no dolor torácico. Niega dolor en miembros inferiores. EF: Clínicamente estable, a nuestra valoración se encuentra eupneica en reposo, sin uso de musculatura accesoria. Saturando 96% (GN 2 lpm). Afebril. Constantes esta mañana: TA: 116/45 mmHg, FC: 50 lpm, Tª: 36.2ºC. Sat: 97% (GN 2 lpm). AC: tonos hipofonéticos, rítmicos, bradicárdicos a 48 lpm. AP: MVC sin agregados. MMII sin edemas ni signos de TVP. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: *AS a destacar: Hb normal, plaquetas normales, no elevación de RFA, función renal conservada, hemostasia normal. No le han hecho el DD ni NTproBNP. *GA (FiO2???): pH 7.37 pCO2 39 pO2 83 HCO3 22.9 Sat 97.8% *PCR Nuevo Coronavirus 2019-nCoV: NEGATIVO; Detección antígeno SARS-CoV-2: NEGATIVO; *Rx tórax: gran elevación de hemidiafragma derecho con desplazamiento de estructuras mediastínicas contralateral. Cardiomegalia. PLAN: - Conecto su BiPAP para continuar con tto nocturno. Si Sat 92%, avisar para añadir oxígeno. - Solicito AS urgente

con DD, NTproBNP, enzimas cardíacas. Según resultados se ampliará con AngioTC. - Recomiendo solicitar valoración por Cardiología (bradicardia, ampliar estudio de disnea crónica de esfuerzo/ ortopnea). - Seguiremos evolución.

Evolución / Evolució

La paciente mejora progresivamente del déficit neurológico, iniciando rehabilitación en planta que seguirá de forma ambulatoria, consiguiendo marcha con ayuda.
Se ha ajustado dieta a la disfagia.
Presentó disnea inicialmente que ha mejorado desde que mantiene el uso de la BIPAP y O2 supervisado por cuidador.
Se ha mantenido afebril, con TA 130/60 y con FC en torno a 50pm.
MMSE (07/09/2021): 16/30.
A la espera de realizarse ecocardioTT, dada la buena evolución clínica, se decide alta y seguimiento ambulatorio.

Al alta leve hemiparesia atáxica izda con NIHSS: 2, Rankin: 4, barthel: 25.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal

INFARTO VERTEBROBASILAR

Diagnósticos secundarios / Diagnòstics secundaris

ICTUS ISQUEMICO PROTUBERANCIA OCLUSION ACI IZQUIERDA SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO DE BASE

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta

DIETA HIPOSÓDICA TÚRMIX.
- Líquidos con espesante.
- ADIRO 100: 0-1-0
- PLAVIX 75: 0-1-0 una caja y suspender.
- SPIRIVA INH/12 si precisa.
- PANTOPRAZOL 40: 1-0-0

Pendiente realización por vía ambulatoria de Ecocardio y Eco-tiroidea (ya solicitadas, se les avisará).

Control por médico de atención primaria.
Derivar a su endocrino de zona para seguimiento.

Se le avisará para continuar rehabilitación de forma ambulatoria en en centro de salud de Vall d`Alba.

Recomendaciones / Recomanacions

Recuerde que tiene usted la/s siguiente/s cita/s: El Viernes 12 de Noviembre de 2021 a las 12:10: DRA.CAMPILLO(PTA.6)NEUROLOGIA; ubicada en Planta 1 Bloque A Puerta 06 de HOSPITAL GENERAL DE CASTELLO

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta

CONSULTAS EXTERNAS - C. EXT. NEUROLOGIA

SERVICIO DE SALUD ***SERVEI DE SALUT***	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO ***DENOMINACIÓ DEL CENTRE***	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO ***SERVEI***	NEUROLOGIA
UNIDAD ***UNITAT***	
NÚM.DE EPISODIO ***NÚM.D'EPISODI***	
FECHA DE INGRESO ***DATA D'INGRÉS***	01/09/2021
FECHA DE ALTA ***DATA D'ALTA***	14/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO ***PRIMER COGNOM***			
SEGUNDO APELLIDO ***SEGON COGNOM***			
NOMBRE ***NOM***			
CIP DE LA CA ***CIP DE LA CA***		***NÚMERO Hª CLÍNICA*** ***NÚMERO Hª CLÍNICA***	
CIP EUROPEO ***CIP EUROPEU***		***CÓDIGO SNS*** ***CODI SNS***	
SEXO ***SEXE***	Mujer	***FECHA DE NACIMIENTO*** ***DATA DE NAIXIMENT***	
DIRECCIÓN ***DIRECCIÓ***			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Responsable:

ADJUNTO

Firma digital / Signatura digital:

Sección / Secció: NEUROLOGIA

Fecha / Data: 17/07/2026 19:07:41

Fecha creación / Data creació: 14/09/2021